

## 年次有給休暇の 現状と課題

### ▶ 年休取得をためらう日本人

日本における年休の平均付与日数は18.2日で、取得日数は平均約9日、取得率は約5割。取得率は、平成初期には55%程度でしたが、その後低下、近年5割に満たない状態が続きましたが、最近上昇に転じました。

「年休取得にためらいを感じる」が2割超、「ややためらいを感じる」が4割超で、労働者の6割以上がためらいを感じています。理由は、「みんなに迷惑がかかるから」が7割超、次いで、「後で多忙になるから」が4割超、「職場の雰囲気取得しづらい」が3割弱です。

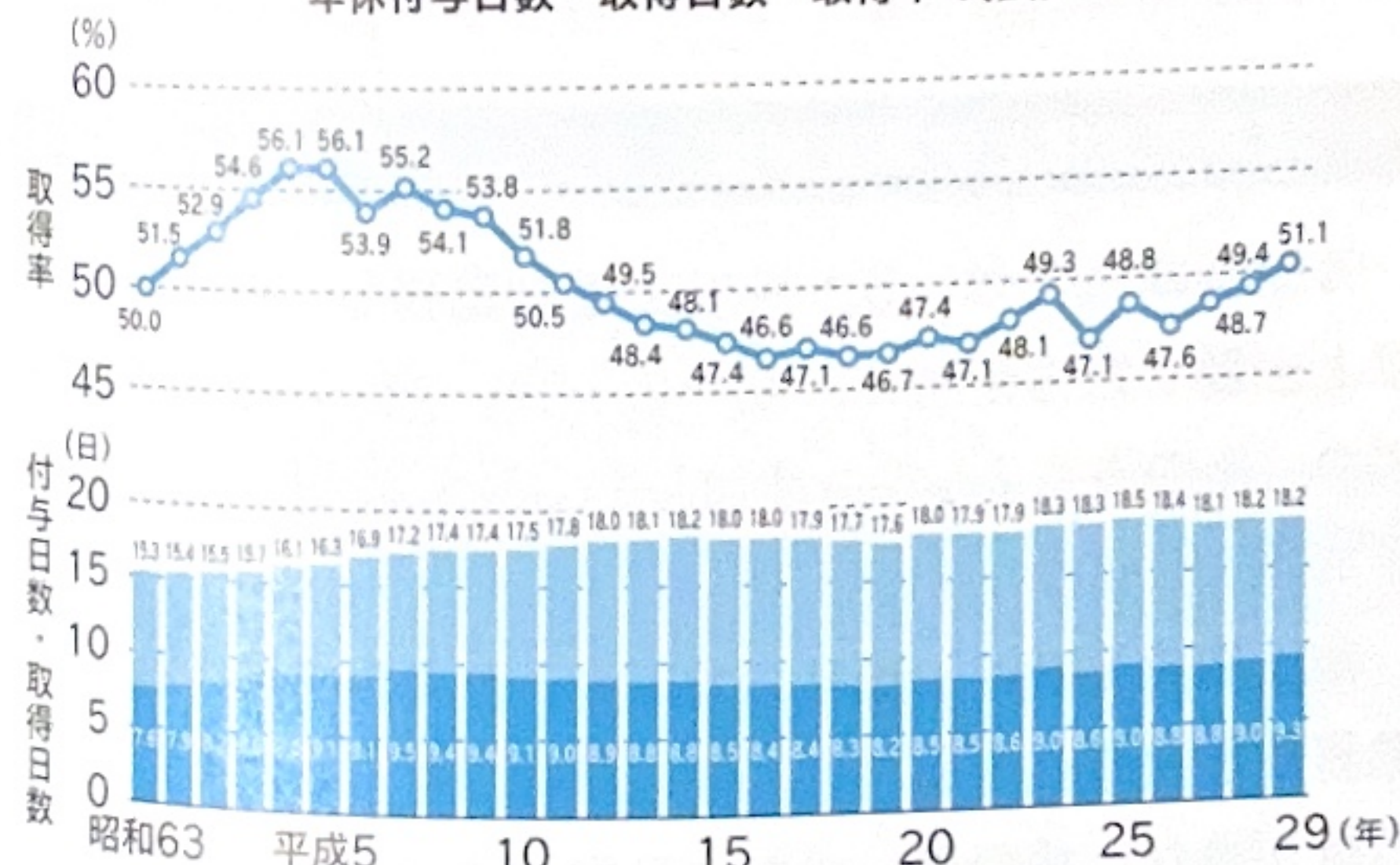
### ▶ 完全取得させる欧州諸国

別調査では、年休を取り残す理由は、「病気や急な用事のために残しておく必要があるから」約64%、「休むと職場の他の人に迷惑になるから」約60%、「仕事量が多すぎて休んでいる余裕がないから」約53%、「休みの間仕事を引き継いでくれる人がいないから」約47%などです。

欧州諸国では、勤続年数にかかわらず、20~30日の年休が付与され、基本的にはすべて取得されています。これは、労働者の希望を聞くなどしたうえで、事業者の責任で年休を完全取得させているからです。

## 年次有給休暇の現状

年休付与日数・取得日数・取得率の推移



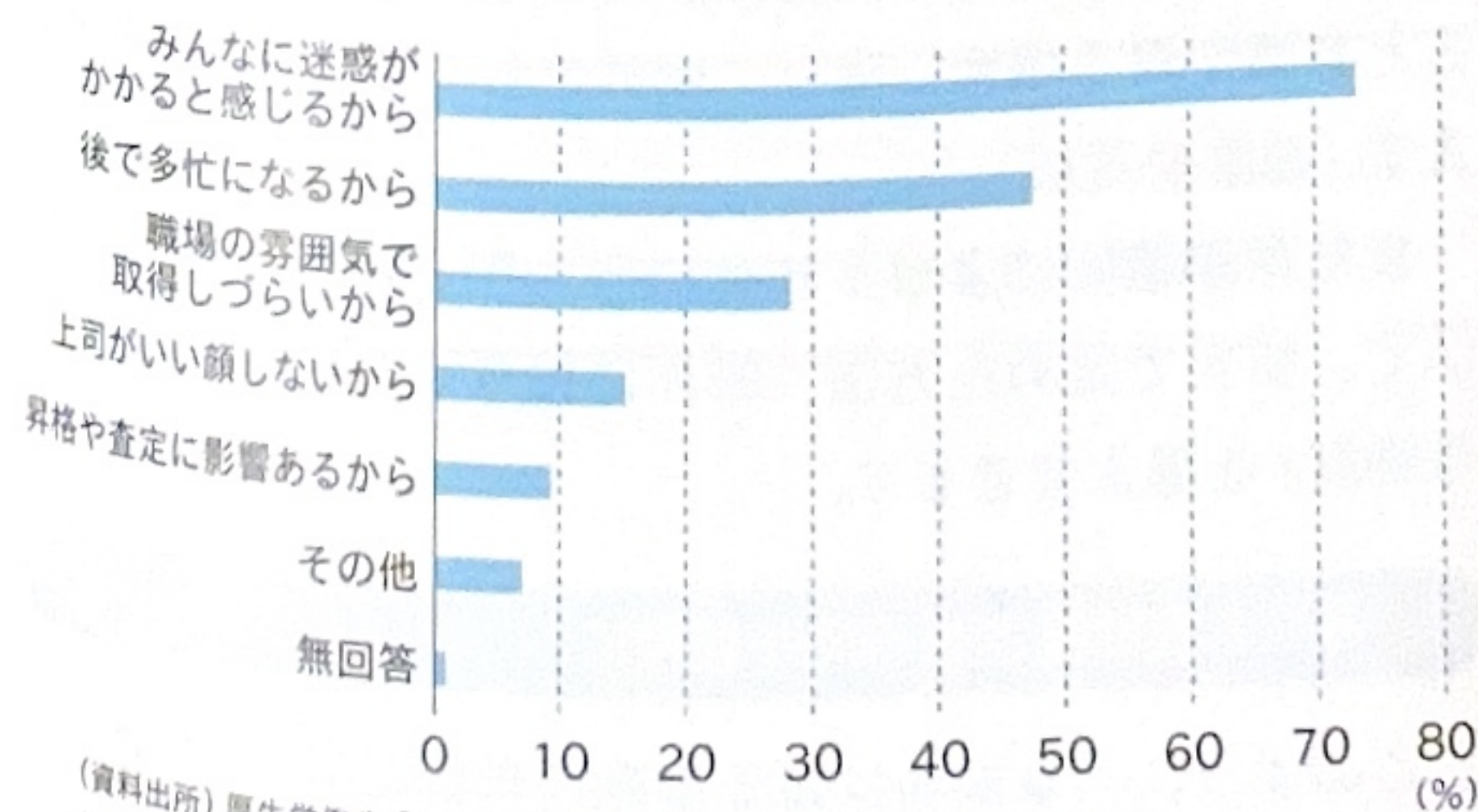
(資料出所) 厚生労働省「就労条件総合調査」

(注) 1) 「対象労働者」は「常用労働者」から「パートタイム労働者」を除いた労働者である。

2) 「付与日数」には、繰越日数を含まない。

「取得率」は、全取得日数/全付与日数×100 (%)である。

年休取得をためらう理由(複数回答)



(資料出所) 厚生労働省「仕事と生活の調和の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」(平成26年)

## ▶ 時季指定権と時季変更権

労働基準法では、6カ月以上継続勤務し、前年度に8割以上出勤した労働者に、初年度10日、その後2年間は1日ずつ、その後は2日ずつ増加して、最大20日の年休が付与されることになっています。

非正規労働者は、通常の労働者より勤務時間は短くても、勤務日数が同じであれば、同じ年休が付与されます。勤務日数が少ない場合は、少ない日数に比例した年休が付与されます。例えば、週3日勤務ならば、初年度は5日、最大で11日です。

年休をいつ取得するかは、基本的に労働者の権利であり、自ら指定できます（時季指定権）。ただし、指定日に休まれると事業が滞る場合に限り、例外として事業者は変更できます（時季変更権）。

また労使協定により、年休のうち5日を除いたものについて、協定で定めた方法、時期に付与する制度（計画的付与制度）を導入できます。

## ▶ 年に5日取得させるのが義務に

このように、事業者は毎年度勤務年数に応じて年休を付与しなければなりませんが、いつ取得するかは労働者の時季指定によるもので、実際に年休が取得されなくても、法

的には問題にならないという制度となっていました。

しかし、今回の改正によって、事業者は必ず少なくとも年休を5日は取得させなければならない義務が創設されました。

## 年次有給休暇の付与

- 6カ月以上継続勤務した労働者に年休を付与

| 初年度 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7年度以降 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日   |

- 年休は、原則として、労働者が指定した時季に取得する（時季指定権）  
その時季に取得させると事業の遂行を阻害する場合は、事業者が変更できる（時季変更権）
- 労使協定により、協定で定めた方法、時季に付与する制度（計画的付与制度）

労働者が時季指定しない場合は年休は取得されなかった

労働基準法改正により年休を取得させる義務を創設

## ▶ 年休付与が10日以上で義務化

事業者は、年休付与日数が10日以上労働者には、5日以上の年休を取得させる義務があります。一般労働者や週5日勤務のパート労働者は、初年度の付与が10日なのですべて対象です。勤務日数が少ないパートも、勤続年数が長くなり、付与が10日になった年度から対象になります。

事業者は、年休のうち5日は、各労働者にいつ年休を取得したいか希望を聞いたうえで、なるべく希望に沿うよう、他の労働者の希望や業務との関係を調整して、具体的な日を指定します。また、事業者は年休付与年度の早い時期に、このような手続きを経て、各労働者の年休取得時季を指定する必要があります。

## ▶ 年休の計画的付与

年休の計画的付与制度は、各事業場において、労働者代表との合意によって、各労働者の年休のうち5日を除くぶんについて、年休の取得日を決める仕組みです。

この制度によって取得時季が決められている場合、その日数に関しては事業者が時季指定する必要はありません。計画的付与によって5日以上取得が決められていれば、今回の改正による義務を履行していることになります。

また、労働者が時季を指定して取得した場合には、事業

者はその日数分は時季指定して取得させる必要がありません。つまり労働者が自分で5日以上時季指定して取得していれば、この義務はなくなります。

年休は、労働者が働く義務がある、企業の所定労働日に取得させなければなりません。事業者が既存の企業休日である、夏休み、年末・年始休み、創業記念日などを指定して年休を取得したことにするような扱いは許されません。

年休を取得させる義務が創設されたこと、取得促進には、そもそも状況の把握・管理が必要なことから、新たに年休の取得状況を記載する年休管理簿を作成しなければならなくなりました。これは労働基準法・規則に基づき作成が義務づけられる書類で、賃金台帳などと同じように3年間の保存義務があります。

## 年休を取得させる義務

- 事業者は、年休のうち5日について、時季を指定して、取得させなければならない。
- 年休を確実に取得させるため、年休管理簿の作成を新たに義務化。

## 留意事項

- 対象は、年休付与日数が10日以上労働者。
- 事業者は、時季指定する際に、各労働者の希望を聴取し、できるだけ希望に沿うようにしなければならない。
- 計画的付与制度によって5日以上年休の取得日が決まる場合には、この義務を果たしたことになる。
- 労働者が時季指定をして年休を5日以上取得した場合には、この義務を果たしたことになる。
- 年休は、働く義務がある所定労働日に取得させなければならない。

## ▶ トップが年休取得できる体制にする

日本の年休取得率は5割程度にとどまります。最低5日は事業者の責任で取得させることが義務付けられましたが、本来完全取得されるべきものです。企業は、新たな義務の履行だけではなく、完全取得への取り組みが必要です。

まず企業トップが、年休取得に向けた指導力を発揮します。取得にためらいを感じる人が多い状況を変えるため、社内で年休の完全取得を共通理解としていくことが必要なのです。また、年休を取得すると職場に迷惑がかかる、後で多忙になると考える人も多いので、完全取得を前提とした職場の人員体制、業務体制とすることも大切です。

## ▶ 完全取得のための労使の話し合い

そのうえで、労使で話し合い、計画的付与制度を導入することは、年休取得の促進方法として有効です。新たに義務付けられた5日にとどまらず、広く活用に向けた話し合いが望まれます。また、労働者が自ら時季指定することを促すため、各企業において、週休日や祝日に年休を加えて連続休暇とする方法（プラスワン休暇）、GW、夏休み、シルバーウィークなどに1週間以上の長期休暇を取得する方法、学校行事や地域のお祭りの際に取得する方法など、さまざまな工夫がされることが望まれます。

## 年休取得促進のために

年休は本来完全取得するもの  
\*欧米では当然の前提

- トップのリーダーシップ
- 職場の共通理解

年休完全取得を前提とした業務体制

## 年休の取得形態

- 連続取得して旅行など
- 1日単位で取得して日々の用事など  
\*ILO条約では2週間以上の連続取得義務

計画的付与制度の活用

プラスワン休暇

四季折々の連続休暇

キッズウィーク

企業のトップが  
休みやすい会社にするために  
指導力を発揮しなければなりません



## 労働者の健康状況

### ▶ 増え続ける有所見率

職場の定期健康診断における有所見率は、労働者の高齢化などが要因で、平成3年の27.4%から年々上昇しています。有所見者が多い診断項目は、血中脂質、血圧、肝機能、血糖などです。また、国民生活基礎調査によれば、労働力人口の約3分の1は何らかの疾病を持ちながら働いています。高血圧330万人、糖尿病160万人、アレルギー114万人、メンタル65万人、心疾患82万人、がん31万人などです。

### ▶ 健康経営を目指す

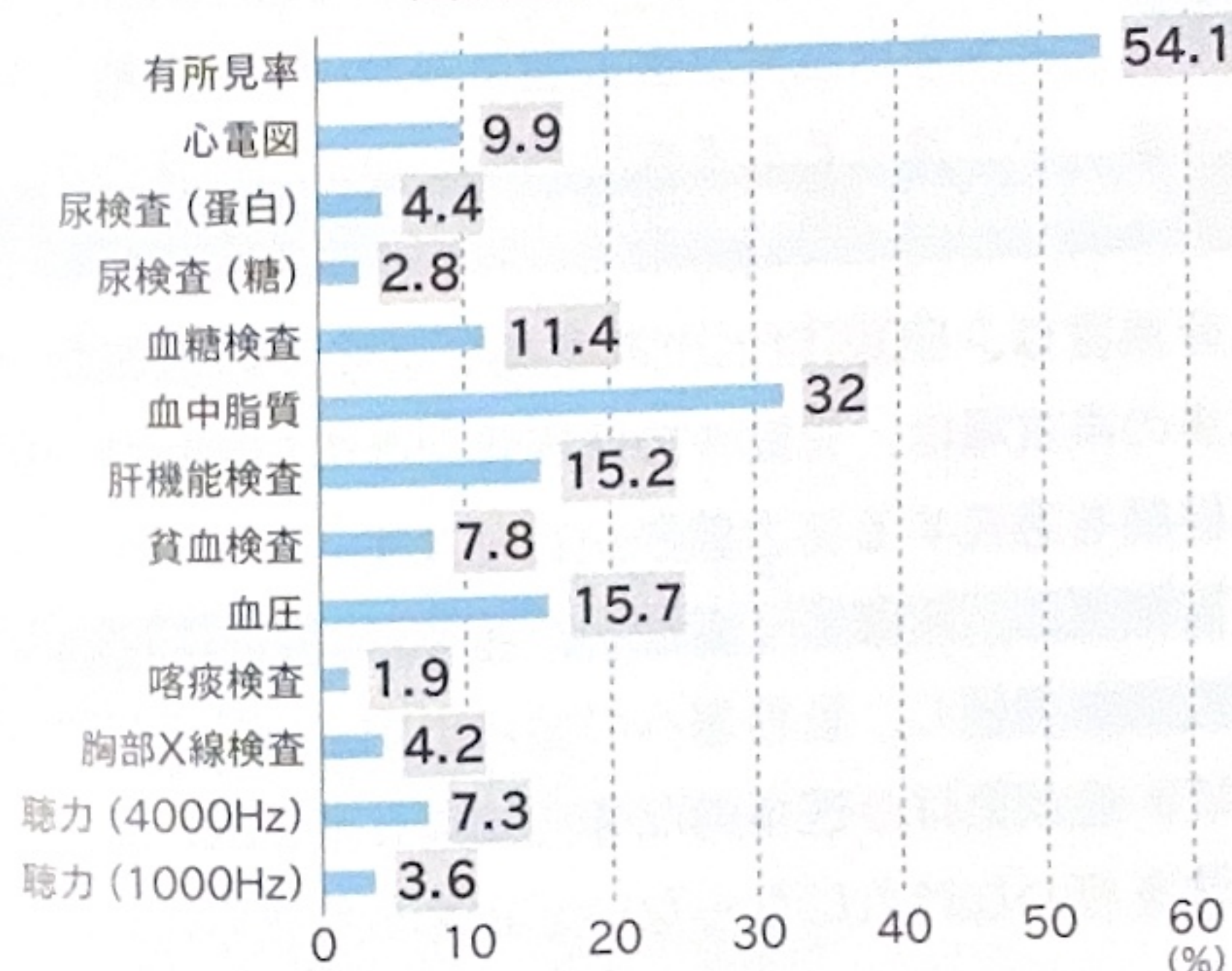
近年、労働者のメンタルヘルスやストレスへも関心が強まっています。労働者の59.5%が、仕事の質・量、仕事の失敗・責任の発生、セクハラ・パワハラを含む対人関係、役割・地位の変化等などで強いストレスを感じています。

業務上疾病は、長期的には低下してきていますが、近年は7000人台で推移しており、平成28年には7361人でした。最も多いのは、腰痛4722人で、ほかに熱中症462人、化学物質によるもの213人、じん肺210人などが含まれます。

このように、健康上の注意が必要な労働者が多数おり、産業保健体制を整え、労働者の健康管理に万全を期すとともに、さらに健康経営を目指すことが望まれます。

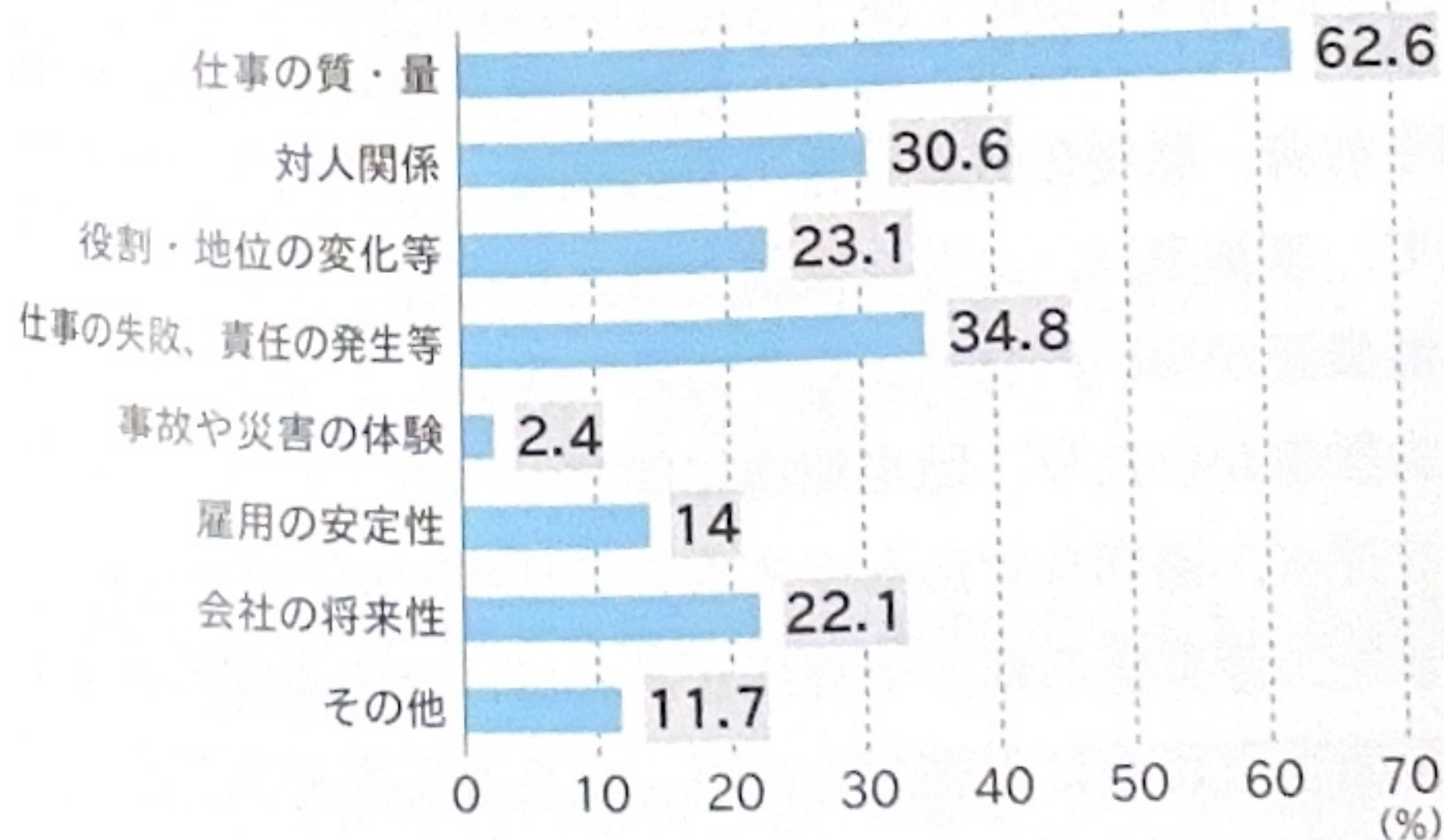
## 労働者の健康の状況

### 定期健康診断結果



(資料出所) 厚生労働省「定期診断結果報告」(平成29年)

### 強いストレスを感じている原因



(資料出所) 厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」(平成29年)

(注) 1) 対人関係にセクハラ、パワハラを含む。

2) 役割・地位の変化等は昇進、昇格、配置転換等である。

### 事業場の規模と産業医の選任義務

産業医は、50人以上の事業場で選任が必要です。50人未満の事業場は、労働者の健康管理等の知識を持つ医師が保健師を選任する努力義務があります。

産業医は、研修修了者など、産業保健の専門的知識がある医師を選任し、監督署への届け出が必要です。今回の改正で、産業医は、医学的な専門知識に基づき、誠実にその職務を行わなければならないと定められました。

### 産業保健活動の適切な実施

産業医は、健康診断、ストレスチェック、面接指導等の実施、それらの結果に基づく対応、健康教育・相談、労働衛生教育、職場の健康障害の原因調査・再発防止などが職務で、事業者は、必要な権限を与えねばなりません。

産業医が専門的立場からこれらを実施し、異常所見のある労働者がいたり、職場環境に問題があれば、事業者意見に意見を述べ、適切な対応を促すなどの連携が必要です。

また、産業医の解任や辞任があれば、その事実と理由を労働衛生委員会に報告しなければならなくなりました。労働者代表が参画する場で、事業者が恣意的に産業医を交代させていないか確認できるようにするためです。

産業医を中心とした産業保健活動が十分に実施されるよ

う、保健師、看護師、心理職などの専門スタッフの配置など、適切な体制構築の努力義務が創設されました。事業場の規模、業種などの状況を踏まえた対応が求められます。

また労働者が、気楽に相談できるよう、新たに、事業者は、産業医等の業務の内容、健康相談の申出方法等を労働者に周知しなければならないこととされました。

## 産業保健体制の充実

### 産業医の選任義務

- 50人以上の事業場は選任義務。
  - 1000人以上の事業場、一定の業種の500人以上の事業場
    - 専属産業医
    - 3000人以上の事業場 — 複数の産業医
- 50人未満の事業場は産業保健の知識がある医師・保健師に委嘱する努力義務。

産業医の責務として、医学的知識に基づいて、誠実に職務を行わなければならない旨の規定が新設

適切な産業医を選任

### 産業医の身分保障の強化

- 労働衛生委員会の報告事項に産業医の解任・辞任を追加。
  - 恣意的な産業医の解任、辞任の強要を防止

### 産業保健体制の整備

- 産業医等による健康管理等が適切に実施できるよう、体制整備する努力義務。

保健師、看護師、心理職など産業保健スタッフの配置など

### 産業医の業務内容等の周知

- 労働者に対して、産業医の業務内容等を周知すること（新規）。

## 長時間労働者の健康確保

### 医師による面接指導の義務づけ

脳・心臓疾患発症の予防のため、長時間労働により疲労が蓄積した労働者に対し、医師による面接指導の実施が義務づけられています。

これまでの対象者は、1カ月当たりの時間外・休日労働が100時間を超える人でしたが、労働安全衛生法施行規則の改正により、80時間を超える労働者に拡大されました。

該当する労働者から申し出があれば、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。

また、高度プロフェッショナル制度の対象者と研究開発業務の従事者については、時間外・休日労働が月100時間を超えた場合、申し出のあるなしに関わらず、医師の面接指導の実施が義務づけられています。

そして事業者は、面接指導した医師の意見を聞き、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数削減などの適切な措置を講じなければなりません。

### 産業医への情報提供も必要

この面接指導が適切に実施されるには、すべての労働者の労働時間の適切な把握が必要です。

今回改正により、労働時間の状況について、客観的、適切に把握することが義務づけられました。管理職や裁量労働

対象者など、賃金台帳作成の関係では労働時間の把握が義務づけられていない人も対象になっています。

また、労働時間の状況を把握して、1カ月当たり時間外・休日労働が80時間を超える労働者がいた場合には、その情報を産業医に提供しなければなりません。産業医はこの情報をもとに、労働者に対して医師の面接指導を受けることを勧奨することとされています。

### 健康確保措置の強化

#### 長時間労働をしている労働者の健康確保

- 長時間労働をしている労働者に対する医師の面接指導の対象拡大  
月100時間超 ⇒ 月80時間超

- 事業者はすべての労働者の**実際の労働時間の状況**を把握しなければならない。

- 管理監督者、裁量労働制対象労働者などを含むすべての労働者が対象
- 高度プロフェッショナル制対象労働者、研究開発業務で時間外・休日労働の法的上限適用除外対象者は罰則付き

- 月80時間超の労働者の情報を**産業医に提供**

産業医は情報をもとに、労働者に**面接指導の申し出を勧奨**  
\* 面接指導が必要な状況の労働者が確実に受けるため

#### 産業医等による面接指導

- ➡ 事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見聴取
- ➡ 事業者による産業医等の意見を踏まえた必要な措置

## 労働者の健康確保のための措置

### ▶ 定期健康診断の実施義務

事業者は毎年1回、労働者の定期健康診断を実施しなければならず、有害業務等に従事する労働者には半年に1回の特別な診断が必要です。パート労働者は、所定労働時間が正規労働者の4分の3以上ならば対象、2分の1以上は努力義務です（ストレスチェックも同様）。

事業者は、診断で異常所見があった労働者に必要な措置を医師などに聞き、必要ならば、作業の転換、労働時間短縮などを講じ、診断結果を労働者に通知すること、健康の保持に努める必要がある労働者に医師等による保健指導を行うよう努めることなどが義務づけられています。

### ▶ ストレスチェックの実施義務

50人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務づけられ、50人未満は当面努力義務です。事業者は、医師、保健師などによるチェックを実施しなければなりません。

結果は、実施した医師などから直接本人に通知され、本人の同意なく事業者へは提供できません。一方、高ストレスで面接指導が必要だと医師が判断した労働者の申し出があれば、事業者は医師面接を実施しなければならず、面接結果に基づき、医師の意見を聞いて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じなければなり

ません。また、ストレスチェックは、集団的分析により、職場改善にもつなげることが望ましいとされています。

産業医の労働者の健康管理等に関する勧告に関して、産業医の勧告に即した対応が確実に図られるよう、産業医は事前に事業者へ勧告内容への意見を聞くこと、勧告があった場合は事業者が労働衛生委員会に報告すること、事業者は勧告を尊重することが定められました。

### 健康確保のために必要な措置の確実な実施

長時間労働をしている労働者の面接指導結果

健康診断における異常所見

ストレスチェックを踏まえた医師の面接指導結果

産業医等の意見を聞いて

健康管理を適切に行うため必要な情報(新規)

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等健康確保のために必要な措置

● 産業医は労働者の健康確保のために必要と認める時は、事業者に勧告できる。

- 産業医は勧告するときは、あらかじめ、勧告内容について、事業者の意見を求める(新規)。
- 事業者は、勧告を尊重しなければならない。
- 事業者は、勧告内容等を衛生委員会に報告しなければならない(新規)。
- 事業者は、勧告内容等を3年間保存しなければならない(新規)。

### ▶ 取扱規程を策定する必要

健康診断結果など、労働者の健康情報は、事業者が労働者の健康を確保し、安全衛生配慮義務を果たすために必要なものです。一方、ほとんどが個人情報保護法の規定する「要配慮個人情報」でもあります。

そのため、労働者に不安を抱かせず、かつ必要なデータを収集するため、事業者は、当該事業場での健康情報の適正な取り扱いについて明確にする必要があります。

厚生労働省は、平成30(2018)年9月、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表しています。事業者は、この指針を踏まえ、それぞれの事業場の業務内容などに応じて、安全衛生委員会などで検討したうえで、健康情報の取扱規程を策定する必要があります。規程では、健康情報を取り扱う目的を明確にし、取扱方法、担当者ごとに取り扱う情報範囲、適正管理の方法、開示・訂正等の方法、苦情処理などについて定めます。

### ▶ 誰が、どの情報を扱うのか

健康情報のうち、労働安全衛生法による定期健康診断結果など、法令に基づいて取得するものがありますが、それ以外の情報の取得には労働者本人の同意が必要となります。

また、法令や本人の同意によって取得した情報であっても、それぞれその目的の範囲で利用しなければなりません。

また、事業者、人事担当者、上司、産業医、産業保健スタッフなど、それぞれの立場によって、取り扱える健康情報の範囲は異なります。健康情報が、不必要な人にまで共有されるようなことがあってはなりません。

### 健康情報の適正管理

- 労働者の心身の状態に関する情報の収集・保管・使用は、必要な範囲内とすること（新規）。
- 心身の状態に関する情報は適正に管理すること（新規）。

- 労働者の心身の状態に関する情報は、個人情報保護法の要配慮個人情報である。
- 労働者の健康確保措置や安全配慮義務の履行のため必要な範囲とすること。
- 労働者の業務内容等によって、必要な範囲は異なる。
- 情報の性質によって、取り扱いの原則は異なる。
- 事業者、人事担当者、上司、産業医、産業保健スタッフなど取扱者によって異なる。

- 心身の状態に関する情報の適正な取扱規程を整備すること。

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針（平成30年9月7日）

### ▶ 病気治療と仕事の両立支援

疾病を抱えた人の治療と仕事の両立は重要な課題です。働き方改革実行計画も、対策の充実・強化の方針を示し、平成28(2016)年2月に厚生労働省が、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表し、両立支援の制度・体制を示しています。

具体的な進め方としては、両立支援が必要な労働者からの申し出から始まり、主治医からの情報——症状、就業の可否、望ましい就業上の措置などを事業者へ提出、その情報に対する産業医などの意見を聴取、主治医と産業医などの意見から仕事の継続可否を判断し、可能ならば就業上の措置、治療への配慮内容の検討・決定などが示されています。

### ▶ 企業と病院・主治医の連携が重要

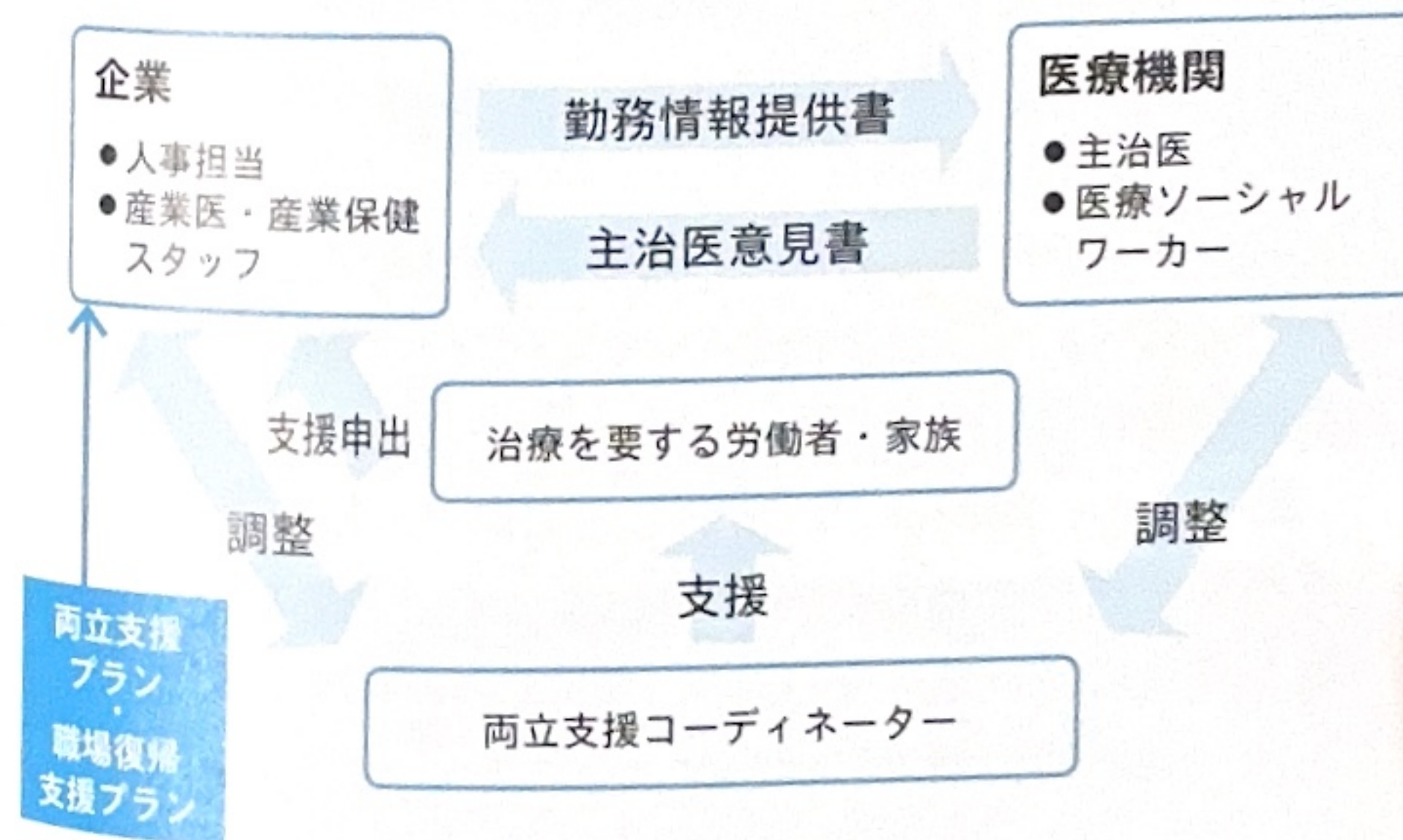
両立支援には、企業と病院・主治医の連携が重要です。厚労省では、平成30年3月、ガイドラインの参考資料として、具体的な連携方法を示した、「企業・医療機関連携マニュアル」を公表しています。

患者に寄り添う両立支援コーディネーターを加えたトライアングル型のサポートが重要であり、その体制整備が進められています。その活用を含め、病気でも働き続けられる環境整備が望まれます。

### 治療と仕事の両立

- 治療を要する労働者について、事業者と医療機関が治療情報を共有し、継続的に支援することが求められる。

- 私傷病であるので、労働者の申し出によることが基本。
- 機微な健康情報にかかわるので、情報管理が重要。
- 「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」及び「企業・医療機関連携マニュアル」を参照。



病気でも働き続けられる環境が望まれます

## モーレツ社員は自慢にならない

戦後復興期から高度成長期にかけて、わが国産業の競争力の源泉として、日本人の勤勉性が指摘されてきました。かつて、モーレツ社員という言葉もありました。

そのような背景もあって、わが国の総実労働時間は欧州諸国に比べると相当長く、また、年次有給休暇は半分程度しか取得されないという状況が続いています。

もちろん、勤勉なのはよいことであり、働き方改革は勤勉を否定するものではありません。重要なのは、働く場合においてメリハリをつけて、働くときは、勤勉に、効率的に働き、休む時はしっかり休むということです。

働き方改革は、日本の企業文化や日本の働くということに対する考え方を変えようとするもので、長時間労働を自慢したり、年休を取得しないことを評価するようなことをなくしていくことを目指すものです。

今後、仕事が早くて的確である、やるべき仕事はしているのに年休は完全取得しているということが評価される社会になることが期待されます。



## 第5章

# 同一労働同一賃金の実現